脑血管疾病的警钟：如何及早发现并治疗脑血管疾病?

狄海莉，孙岭岭 *
（西北大学第一医院神经内科，陕西 西安 710043）

【摘要】脑血管疾病的类型多种多样，常见的有脑出血、脑梗死、蛛网膜下腔出血等。一旦发生这些疾病，除了威胁患者的身体健康，还会对家庭和社会造成较大负担，必须高度重视。然而，很多人并不知道如何尽早发现脑血管疾病的发生，更不知道该疾病的治疗方法。通过本文的一一科普，帮助及早发现疾病并进行针对性的治疗，保障患者的身体健康。

【关键词】脑血管疾病；脑出血；脑梗死；蛛网膜下腔出血
【中图分类号】R743.34　【文献标识码】A　【文章编号】2096-2665.2025.18.0145.02
DOI：10.3969/j.issn.2096-2665.2025.18.040

1 脑血管疾病的概述

脑血管疾病是一种由于颅内血管病变，引发脑组织损伤和功能障碍的疾病，其可分为缺血性脑血管病（因血管堵塞导致脑组织缺血坏死）和出血性脑血管病（因血管破裂出血压迫脑组织）两大类。脑血管疾病发病急骤，患者常骤然出现言语不清、一侧肢体麻木或瘫痪、口角歪斜等症状，严重者可伴有意识障碍、昏迷甚至死亡，对患者生命安全和生存质量构成严重威胁。

脑血管疾病的发生与大脑独特的生理特性密切相关。脑组织代谢需要持续丰富的血液供应以输送氧气和葡萄糖，因此对缺血、缺氧异常敏感。大脑的血供主要依赖于颈内动脉系统和椎－基底动脉系统，二者通过颅底的 Willis 环形成一个有效的侧支循环代偿网络，在一定程度上保障了脑血流的稳定与平衡。然而，随着年龄的增长，动脉粥样硬化成为最主要的致病因素，此过程始于血管内皮损伤，脂质等物质继而在血管壁沉积形成斑块，致使管腔逐渐狭窄、硬化，血流动力学受到影响 [1]。此时，在诸如情绪激动、剧烈活动、血压骤然升高等诱因的刺激下，这些不稳定斑块可能破裂并形成血栓堵塞血管，或薄弱的血管壁在高压下破裂，都会最终导致脑卒中事件的发生。

2 脑血管病的早期症状

2.1 **头痛**　在脑血管疾病的发病早期，突发剧烈头痛是一个需要高度警惕的核心临床症状。患者常描述为头部有爆炸样、撕裂样的剧痛，或伴有明显的压迫感、胀痛感及针刺感。若头痛在某一部位固定出现，其疼痛性质、强度或模式不同于患者往常的任何经历，且病情可能在短时间内逐步加重，甚至伴随恶心、呕吐等症状时，必须引起高度重视，这极可能是蛛网膜下腔出血或脑出血的典型前兆。

2.2 **言语障碍**　脑血管疾病发生后，部分患者可表现为发音含糊、吐字不清、语速缓慢，或虽能理解他人语意，却难以组织词汇、无法自主表达完整句子，严重者甚至完全丧失语言能力。其根本原因在于，大脑中负责语言功能的中枢因缺血或出血性损伤而受损，导致语言的理解、形成或表达过程受阻。需要强调的是，言语障碍不仅是脑血管病的重要表现，也常是发病的预警信号。

2.3 **肢体无力**　脑血管病另一典型的症状是突发性的肢体无力，患者往往突然感到一侧身体麻木、沉重或力量减弱，严重时该侧肢体可能完全瘫痪，丧失自主活动能力。这种无力症状通常在起病后短时间内达到高峰，且具有明显的偏侧性特征，其原因在于，大脑中负责支配对侧肢体运动的神经通路因缺血或出血性损伤而中断，导致大脑发出的指令无法有效传递，从而表现出对肢体的控制力显著下降或丧失。

2.4 **视觉异常**　脑血管疾病常伴随视觉异常，突然出现的视野缺损、视力模糊、视物重影等症状，这些视觉障碍既可表现为短暂性发作，也可持续存在，其严重程度与损伤范围密切相关。其发病机制在于，大脑枕叶的视觉中枢或与之相连的视觉传导通路因脑部供血障碍而受损，导致信号接收、整合或传递过程发生中断。视觉异常不仅是脑卒中后的常见后遗症，也常是发病前的预警信号。

2.5 **平衡障碍**　平衡障碍是脑血管疾病的典型症状，患者往往突然出现严重的眩晕感，感觉自身或周围环境旋转，并伴有持续的头晕、站立不稳、步态蹒跚，甚至无法

作者简介：狄海莉，大学本科，副主任医师，研究方向：神经内科疾病的诊疗。
通信作者：孙岭岭，硕士研究生，主治医师，研究方向：神经内科疾病的诊疗。E-mail：sunlingling0101@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

独立行走或维持站立。其核心病因在于，供应小脑、脑干等平衡中枢区域的血管发生阻塞或破裂出血，导致这些负责协调躯体平衡、空间定位及运动调节的神经结构受损，进而严重破坏机体维持姿态稳定的能力。需要强调的是，突发的平衡障碍不仅是脑卒中的核心表现之一，也可能成为后遗症状长期存在。

2.6 **其他症状** 突发或频繁的鼻出血、眼结膜出血等非典型症状，虽多数与脑血管疾病无关，但可能是颅内血压骤升或血管稳定性变差的外在信号。一旦出现此类无明确原因的异常出血，应视为健康警示，并及时就医筛查，以排除脑血管疾病病变风险，争取早期干预。

3 如何尽早发现脑血管疾病?

3.1 **定期体检** 定期进行血糖、血压及血脂等指标检查，便于在脑血管疾病的危险因素出现时尽早发现并提出针对性的解决措施 [2]。

3.2 **关注机体变化** 密切关注机体变化进行，如有头痛、言语障碍、肢体无力、视觉异常、精神与神经症状、平衡障碍等脑血管疾病的早期症状，则不可掉以轻心，及时到医院检查，避免错过最佳的治疗时机。

3.3 **关注生活习惯** 培养健康的生活习惯，戒烟酒，科学合理饮食、适当运动等，对脑血管疾病的预防均具有一定作用。

3.4 **关注家族史** 若家族中有脑血管疾病史，更应该在日常生活中采取有效的措施预防脑血管疾病，且定期进行有关的检查。

4 脑血管疾病的治疗方法

4.1 **急性期治疗** 脑血管疾病患者处于急性发作期，需立即就医，尽早接受专业医生的诊断和治疗。

4.1.1 *药物治疗* 脑血管疾病的发生，可以使用的治疗药物类型多种多样，阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药物，对血栓形成的预防有促进作用；达比加群、华法林等抗凝药物，主要用于脑栓塞或心房颤动等血栓性疾病的预防和治疗；钙通道拮抗剂、利尿剂等降压药物及血管紧张素转换酶抑制剂等，适用于高血压的控制，从而降低脑血管疾病发生率。

4.1.2 *手术治疗* 手术治疗包含介入治疗和微创手术治疗。介入治疗中溶栓治疗是给患者注射溶栓药物，溶解血栓。机械取栓是将取栓装置通过导管送至血栓部位，将血栓直接取出，加快脑血流的恢复速度。血管内支架植入是通过导管将支架送入闭塞或狭窄的血管部位，将血管撑开，促进血流恢复。

微创手术治疗中颅内血肿微创清除术是在 CT 定位下通过穿刺针将血肿液化后引流，减轻血肿对脑组织的压迫，适用于出血量 20~50 mL、位置相对表浅的患者。脑室穿刺引流术是通过穿刺侧脑室放置引流管，释放脑脊液，降低颅内压，预防脑疝 [3]。颈动脉内膜切除术可通过小切口切除增厚的颈动脉内膜和斑块，改善脑部供血。

4.1.3 *康复治疗* 脑血管疾病的康复治疗也尤为重要，在积极进行生命支持的同时需尽早介入康复措施，包括通过心理疏导缓解患者焦虑、抑郁情绪，指导患者进行口腔肌肉锻炼和言语训练以改善语言功能，为后续恢复期系统康复奠定基础，全面提升患者预后生活质量。

4.2 **恢复期治疗** 脑血管疾病恢复期是功能恢复的关键阶段，患者需严格遵医嘱用药并坚持系统康复。此阶段需通过药物严格控制血压、血糖及血脂，以预防疾病复发；同时，在专业康复师指导下开展个性化、全面的康复训练，包括穿衣、进食等日常活动训练以提升生活自理能力，并持续进行运动、言语和认知功能锻炼。可结合针灸、推拿等中医疗法作为辅助，促进神经与肢体功能恢复。此外，患者应定期复查头颅影像等评估恢复进展，以便及时调整治疗与康复方案。

4.3 **生活方式调整** 应建立合理的饮食结构，坚持以低脂肪、低钠及富含膳食纤维的食物为主，以帮助控制血脂、血压水平。还需彻底戒烟并严格限制饮酒，以减少烟草和酒精对血管的直接损害。且需保持规律运动，例如每天进行散步、太极拳、八段锦等锻炼，以增强心肺功能、改善血液循环。将体质量维持在健康范围内，避免肥胖带来的代谢负担。此外，还应保持良好的心理状态，通过社交和兴趣活动缓解压力。

5 小结

脑血管疾病应密切关注身体异常信号，做到早发现、早治疗，从而有效降低疾病的致残率与死亡率。在治疗的同时，积极构建健康生活方式也是预防发病与复发的重要基石。通过推进科学预防、精准治疗及全面照护，我们才能为患者的生命健康提供坚实保障。

参 考 文 献

[1] 陈杰 , 任国勇 , 王炜 , 等 . 急性缺血性脑卒中颈动脉粥样硬化斑块性质影响因素及 ESM-1、Lp-PLA2、miR-21 鉴别价值分析 [J]. 神经损伤与功能重建 , 2024, 19(3): 179-182.

[2] 王凯 , 范小璇 , 唐勇 , 等 . 安康地区中青年高血压性脑出血发病的危险因素及血清学指标分析 [J]. 保健医学研究与实践 , 2025, 22(2): 94-100.

[3] 甘玉兰 , 宋志富 . 经脑室穿刺外引流术治疗脑室出血的进展 [J]. 西南军医 , 2020, 22(2): 131-133.

中国知网 https://www.cnki.net